

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061075-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GILCILENE MAYARA MAFRA DOS SANTOS MARTINS

RECORRIDO: LAURA MAFRA OLIVEIRA

PROCESSO CIVIL - SAÚDE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE INFLIXIMABE 100MG/AMPOLA -AUTORA, 04 ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE RETOCOLITE ULCERATIVA EM AGOSTO DE 2023, EM TRATAMENTO - MEDICAMENTO INCLUÍDO PELO SUS PARA O CASO DA AUTORA - MAS FORNECIMENTO A PATIR DOS 6 ANOS, O QUE CARACTERIZARIA USO OFF LABEL - CONJUGANDO O TEMA 106 DO STJ COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 657.718/MG PELO STF, E EM QUE PESE TRATAR-SE DE USO OFF LABEL, AFASTADO PELO STJ COMO REGRA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO RECURSO ESPECIAL 1.657.156/RJ QUE DEU ORIGEM AO TEMA 106, CONSIDERANDO TRATAR-SE DE DOENÇA COM CONSEQUÊNCIAS RARAS QUANDO MINISTRADA A MEDICAÇÃO TRADICIONAL, O QUE TORNA A ENFERMIDADE SEM TRATAMENTO NO ÂMBITO DO SUS TAMPOUCO INDICAÇÃO DE SUBSTITUTIVO EM TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME MANIFESTAÇÃO DO PRÓPRIO NAT, E PELO FATO DA MEDICAÇÃO PLEITEADA JÁ SER FORNECIDA GRATUITAMENTE PELO SUS - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA ANTE A PRESENÇA AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - AGRAVO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

5061075-43.2024.4.02.5101

510014281325 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061075-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GILCILENE MAYARA MAFRA DOS SANTOS MARTINS

RECORRIDO: LAURA MAFRA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar apresentado pela União contra o deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem, que deferiu a liminar para determinar às rés que, dentro de suas esferas de competências administrativas, forneçam à autora o fármaco **INFLIXIMABE 100mg/ampola**, conforme prescrição e laudos de fls. 17/27 e 18/27 do Anexo 2 de Evento 1, firmados pela médica Dra. Cristiane Tsuge, CRM-RJ 944254, confirmadas pelo NAT, consoante o parecer juntado em 09/08/2024, a partir da intimação desta, com a realização dos exames necessários, prescritos pelo médico na ocasião ou outro que for necessário nas circunstâncias atuais, à vista do real estado de saúde da requerente, sem olvidar da necessidade de eficiência do tratamento e seus custos, sob responsabilidade penal, civil e administrativa dos responsáveis, na forma da lei.

Trata-se demanda relativa ao fornecimento de medicamento.

De acordo com formulário médico da Defensoria Pública da União, documentos do Hospital Municipal Jesus e formulário do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (evento 1, ANEXO2 páginas 12 a 18; 20; dos autos originários), emitidos em 28 e 21 de maio e 02 de abril de 2024, pela gastroenterologista Cristiane Harumi Bazhuni Tsuge Neiva (CREMERJ 52.94425-4), a Autora, 04 anos, com diagnóstico de **RETOCOLITE ULCERATIVA** em agosto de 2023, em tratamento. Apresentou reativação da doença (diarreia com sangue) e necessidade de internação em fevereiro de 2024, cuja colonoscopia evidenciou retocolite ulcerativa em atividade. Necessita de mudança de esquema terapêutico. Já realizou tratamento com Mesalazina, Azatioprina, Metilprednisolona e Prednisolona, sem resposta adequada. Sendo indicado o medicamento Infliximabe 100mg - indução semanas zero, 2 e 6 e após a cada 8 semanas de forma contínua. Foi mencionada a Classificação Internacional de Doenças (CID-10): K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa (crônica):

Paciente: Laura Mafra Oliveria
DN: 21/02/2020
CNS: 898005935833028
Prontuário: 171806
Responsável: Gilcilene Mayara Mafra dos Santos Martins

LAUDO MÉDICO

Paciente Laura, atualmente com quatro anos e três meses, diagnosticada com Doença Inflamatória Intestinal, fenótipo Retocolite Ulcerativa (CID 51.3) desde agosto de 2023. Trata-se de uma doença crônica de natureza autoimune com aumento no número de casos nessa faixa etária nos últimos anos, principalmente nos países desenvolvidos e cujo o tratamento é feito utilizando medicamentos antiinflamatórios e imunossuppressores, com o objetivo de controlar a exacerbação da doença, pois não há cura. Quando a doença se manifesta antes dos 6 anos de vida é classificada como Doença Inflamatória Intestinal de Início Muito Precoce e tem características peculiares em relação à apresentação, evolução, resposta ao tratamento e prognóstico. Considerando o contexto acima, a paciente em questão recebe o tratamento com medicamentos de uso contínuo desde o diagnóstico. Inicialmente, recebeu a primeira linha de tratamento, utilizando mesalazina, azatioprina e prednisolona, porém sem resposta adequada. Laura continua apresentando sinais e sintomas da doença como: perda de peso, diarreia, sangramento retal, febre intermitente, dor articular, apesar de ótima adesão ao tratamento. Necessitou de duas internações recentes devido à febre e perda de peso, totalizando três internações neste nosocômio nos últimos 10 meses descritas a seguir: primeira internação de 13/07/2023 a 22/08/2023; segunda internação: 06/02/2024 a 29/02/2024; terceira internação: 07/05/24 a 17/05/24. Durante a segunda internação foi realizada nova colonoscopia para classificação endoscópica da doença e foi evidenciada Retocolite Ulcerativa em Atividade, o que vai ao encontro das manifestações clínicas, reforçando a ausência de resposta ao tratamento inicial proposto.

Baseado nos dados clínicos e endoscópicos, a conduta foi a alteração da proposta terapêutica para o uso de imunobiológico, especificamente o infliximabe, seguindo protocolos internacionais para o tratamento da doença. Porém, no Brasil, seu uso está licenciado pela ANVISA para doença inflamatória intestinal pediátrica a partir de seis anos, e para população adulta. Os protocolos europeu e norte americano prevêm a utilização dessa medicação na população abaixo dos seis anos (referências bibliográficas em anexo) como opção terapêutica, segundo a posologia: Infliximabe 100 mg/ampola, na dose de 5 mg para cada quilograma de peso (uma ampola), com infusões nas semanas: 0, 2 e 6, para remissão, seguido de manutenção com infusões a cada 8 semanas. Nos primeiros seis meses do tratamento está recomendado associação com azatioprina 50 mg (na dose 2,5 mg para cada quilo) por dia.

A utilização desse medicamento está sendo solicitada como segunda opção para doença refratária. As outras drogas disponíveis foram ineficazes e enquanto isso, a falta de tratamento adequado impacta diretamente a vida de Laura e de sua família, uma vez que Laura está constantemente com o intestino inflamado, comprometendo seu ganho de peso, estado nutricional, desenvolvimento, incapacitando-a de frequentar escola, submetendo-a a diversas internações, exames e procedimentos dolorosos. Faz-se urgente e necessária nova tentativa de tratamento para esta criança.

Estima-se o valor médio do infliximabe entre três a cinco mil reais por ampola. À disposição para qualquer esclarecimento,

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2024.


Dra. Cristiane Tsuge
Gastroenterologista Pediatra
CRM 54154 / RQE 44548

A decisão de 1a instância foi mantida por atender aos parâmetros fixados pelas instâncias superiores.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1a instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

A Autora, 04 anos, com diagnóstico de **RETOCOLITE ULCERATIVA** em agosto de 2023, em tratamento. Apresentou reativação da doença (diarreia com sangue) e necessidade de internação em fevereiro de 2024, cuja colonoscopia evidenciou retocolite ulcerativa em atividade. Necessita de mudança de esquema terapêutico. Já realizou tratamento com Mesalazina, Azatioprina, Metilprednisolona e Prednisolona, sem resposta adequada. Sendo indicado o medicamento Infliximabe 100mg - indução semanas zero, 2 e 6 e após a cada 8 semanas de forma contínua.

O Infiximabe é um anticorpo monoclonal, que neutraliza a atividade biológica do TNF ao se ligar com alta afinidade a formas solúveis e transmembranas do Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-alfa) e inibe a ligação do TNF-alfa a estes receptores. **Dentre suas indicações consta o tratamento de Colite ou Retocolite Ulcerativa adulto e pediátrico (acima de 6 anos)** para redução dos sinais e sintomas; indução e manutenção da remissão clínica; indução e manutenção da cicatrização da mucosa; melhora na qualidade de vida em adultos; redução ou descontinuação do uso de corticosteroides; redução da hospitalização relacionada à colite ou retocolite ulcerativa em adultos; redução da incidência de colectomia em adultos; em pacientes com colite ou retocolite ulcerativa ativa com resposta inadequada aos tratamentos convencionais.

Conforme parecer do NAT (evento 13, PARECER1), o medicamento pleiteado Infiximabe possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e apresenta indicação prevista em bula aprovada pela referida agência, para o tratamento de retocolite ulcerativa, quadro clínico apresentado pela Autora. Contudo, ressaltou que está previsto na bula do medicamento pleiteado Infiximabe, **sua utilização é para uso adulto e Pediátrico acima de 6 anos, e a Autora nasceu em 21 de fevereiro de 2020 e, portanto, apresenta, 04 anos, caracterizando o uso off label.**

No que tange à disponibilização do medicamento pleiteado no âmbito do SUS, insta mencionar que **Infiximabe 10mg/mL é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF4), aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Retocolite Ulcerativa**, e conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS. Infiximabe 10mg/mL é disponibilizado pelo CEAF perfazendo o grupo de financiamento 1A do referido componente: medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estado e Distrito Federal.

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)¹ da Retocolite Ulcerativa o uso de infliximabe na população pediátrica foi testado em estudo clínico randomizado (ECR) e é sugerido como primeira escolha para pacientes com doença refratária a corticoide e sem resposta à azatioprina. O infliximabe é aprovado no Brasil pela ANVISA para uso a partir dos 6 anos de idade. O infliximabe não é preconizado para pacientes menores de 6 anos. **Assim, elucida-se que a dispensação do medicamento Infiximabe 100mg não está autorizada para a faixa etária da Autora, inviabilizando que a mesma receba o medicamento por vias administrativas.**

Novo laudo foi apresentado, esclarecendo o que se segue:

Paciente: LAURA MAFRA OLIVEIRA

Idade: 4

Data: 02/07/2024 12:08:43

Sexo: Feminino

CPF: Não Informado

BAE: 19632

LAURA MAFRA OLIVEIRA
DN: 21/02/2020
Prontuário: 171806
CNS: 898005935833028

LAUDO MÉDICO

Atesto para devidos fins que a paciente Laura, 4 anos e 4 meses, tem diagnóstico de doença inflamatória intestinal de início muito precoce desde agosto de 2023. Recebeu tratamento com mesalazina na dose de 50 mg a cada quilo de peso por dia; azatioprina 2,5 mg a cada quilo de peso por dia; e prednisolona com doses entre 1 e 2 mg a cada quilo de peso por dia, desde o diagnóstico. O tratamento foi feito com doses adequadas e ótima adesão, porém sem obter diagnóstico clínico e endoscópico de remissão da doença, ou seja, com dificuldade de ganho de peso, diarreia crônica, episódios de sangramento retal e febre esporádicos, associados à diminuição da dose do corticóide. Além disso, a colonoscopia de seguimento de 28/02/2024 evidenciou "Retocolite ulcerativa em atividade - Escore de Mayo 3". Dessa forma, considerando a apresentação grave da doença, a extensão, a refratariedade à terapêutica inicial, as opções de tratamento existentes, foi necessário progredir para o uso do imunobiológico anti- TNF, nesse caso, o infliximabe. A conduta está de acordo com protocolo internacional da Sociedade Norte Americana de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição de 2020, sobre o manejo de doença inflamatória intestinal de início muito precoce (referência em anexo). Trata-se de uma subclassificação da doença inflamatória intestinal de início antes dos seis anos, cuja apresentação pode ser mais agressiva, e a refratariedade ao tratamento é bem observada, devendo-se individualizar a conduta.

Dra. Cristiane Tsuge
Gastroenterologia Pediátrica
CRM-RJ: 944254 / RQE-44548

Dr^a. CRISTIANE HARUMI BAZHUNI TSUGE NEIVA

CRM/RJ: 52944254

Com o documento, foi apresentado artigo científico em inglês.

No Parecer do NAT foi elaborado (evento 27, PARECER1), apresentando as seguintes colaborações:

3. Foi acostado ao processo novo documento médico (Evento 20_PET2, página 1), no qual a médica assistente elencou o plano terapêutico utilizado para o quadro clínico da Autora e a justificativa para a indicação do medicamento Infliximabe. 4. Reitera-se que o medicamento Infliximabe apresenta indicação prevista em bula aprovada pela ANVISA, para o tratamento de retocolite ulcerativa, quadro clínico apresentado pela Autora.

5. Complementa-se ainda que, o tratamento medicamentoso para a doença inflamatória intestinal (DII) na criança e adolescente deve ser individualizado, baseado primeiramente na diferenciação entre doença de Crohn (DC) ou Colite Ulcerativa (CU), determinação da localização e extensão da lesão, presença ou não de manifestações extraintestinais e o estado nutricional do paciente. Característica específica da DII pediátrica: atividade da doença é igual à parada ou diminuição de ganho ponderoestatural e/ou puberal, que só se restabelecem com o tratamento eficaz. Tanto DC quanto CU são doenças crônicas caracterizadas por surtos de agudização (atividade ou crise) e períodos de remissão, se o tratamento de manutenção estiver adequado. A terapia nas crianças maiores com uso de imunomoduladores e as descobertas de novos imunobiológicos promoveram uma mudança dramática na prática médica dessas doenças e no modo de administração. Em sua maioria não são administradas por via oral. Mais uma vez, os pacientes pediátricos têm limitações éticas quanto aos estudos abrangentes sobre farmacocinética, segurança e eficácia de qualquer medicamento para DII.

6. Tratamentos clínicos não bem conduzidos ou procedimentos cirúrgicos não bem indicados podem ser piores que a própria doença, com traumas psicológicos devastadores. O tratamento deve ser individualizado e os principais desafios são a indução e manutenção da remissão da doença, o crescimento, a nutrição e os aspectos psicológicos. A transição para os gastroenterologistas de adultos não finaliza os problemas. O gastroenterologista pediátrico precisa ter atenção com as consequências dessa terapia que ocorrerá por muitas décadas, uma vez que a sobrevivência desses pacientes está aumentando. Até que a ciência descubra a cura para a DII com base em novos conhecimentos em imunologia e imunogenética, devemos confiar nas abordagens convencionais extrapoladas dos adultos, mas sempre com a convicção de verificar sua verdadeira eficácia para as crianças e adolescentes, indivíduos em desenvolvimento constante.

7. No momento, não há novas informações a serem abordadas por este Núcleo, renovam-se as demais informações sobre o quadro clínico da Autora e sobre o medicamento pleiteado, dispostas no PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1009/2024, elaborado em 20 de junho de 2024 (Evento 13_PARECER1, Páginas 1 a 5).

Portanto, trata-se de medicamento para uso off label dada a idade da autora. Entretanto, o medicamento é prescrito e fornecimento pelo SUS para o seu caso.

E a urgência estaria caracterizada pelos efeitos deletérios da doença e pela idade da criança, que estaria desnutrida em importante fase do seu desenvolvimento (fl. 18 do evento 1, ANEXO2):

...com azatioprina 50 mg (na dose 2,5 mg para cada quilo) por dia.
A utilização desse medicamento está sendo solicitada como segunda opção para doença refratária. As outras drogas disponíveis foram ineficazes e enquanto isso, a falta de tratamento adequado impacta diretamente a vida de Laura e de sua família, uma vez que Laura está constantemente com o intestino inflamado, comprometendo seu ganho de peso, estado nutricional, desenvolvimento, incapacitando-a de frequentar escola, submetendo-a a diversas internações, exames e procedimentos dolorosos. Faz-se urgente e necessária nova tentativa de tratamento para esta criança.

Do exposto se conclui que: **o medicamento vindicado já foi examinado no âmbito do SUS, sendo fornecido exatamente para a doença da autora, e, apesar de doença ser rara, algumas entidades internacionais relevantes reconhecem seu uso externo e empírico como opção de tratamento para casos como o da parte autora, sendo necessário exames complementares para que se possa atestar seus efeitos a longo prazo, notadamente no que toca à manutenção de seus efeitos favoráveis, segundo a médica assistente.**

O NAT ratifica porém, que, considerando o quadro descrito para a parte autora - de uso deletério e ineficaz medicação dispensada ao SUS para sua doença - **não haveria, no âmbito do SUS, tratamento para sua enfermidade.**

O fármaco pleiteado possui registro vigente na ANVISA e indicações aprovadas em bula para a doença, mas não para a idade. A pretensão, portanto, é de **uso off label de medicamento dispensado gratuitamente pelo SUS** mas que não alcança a idade da autora, a qual, dentro do quadro supra apresentado, não teria tratamento disponível no âmbito do SUS.

A questão, portanto, se restringe à possibilidade de concessão da medicação para uso off label, considerando a **ausência de outro substitutivo para o tratamento da doença no âmbito do SUS, e o fato de que, inobstante a ausência de indicação em bula, o próprio NAT reconhece que o produto seria indicado para a doença rara descrita para a parte autora.**

O STJ, nos autos do Recurso Especial 1.657.156/RJ entendeu que não cabe a concessão pelo SUS de medicamentos para uso off label, essencialmente, com base no artigo 19-T da Lei 8.080/90, lei que rege o SUS e veda o fornecimento de tratamento para fins experimentais, entendendo por tal todo aquele que não possui as indicações descritas na bula ou manual registrado na ANS, conforme definição posta na Resolução Normativa da ANS 338/2013 (tese firmada em julgamento de embargos em 12/09/2018).

Entrementes, o STF, nos autos do Recurso Extraordinário 657.718/MG destacou em que hipóteses seria possível conceder medicamentos sem registro na ANVISA. De acordo com o voto do Ministro Barroso, acompanhado pela maioria dos membros do Tribunal, tal hipótese seria excepcional e apenas admitida uma vez reunidos 3 requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (**salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras**); b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) **a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil:**

*DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO MORA IRRAZOÁVEL NA APRECIÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (**salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras**); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) **a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA.** Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O*

Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União". (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)

Perceba-se que o medicamento em tela tem registro na ANVISA e é fornecido pelo SUS; a questão está no seu uso e **na inexistência de tratamento no âmbito do SUS, conjugado com o reconhecimento, pelo próprio NAT, de que a medicação pleiteada estaria relacionada à doença diagnosticada para a parte autora.**

No caso, **a doença possui tratamento pelo SUS, mas não para a doença da autora, ante ao uso ineficaz e deletério da medicação indicada para o tratamento da doença.** E diante dos consectários excepcionais que tal medicação gera sobre a parte autora, não há indicação da existência de substitutivo terapêutico em âmbito nacional. O medicamento pretendido tem registro na ANVISA mas não para o uso pretendido. O objetivo de seu fornecimento seria controlar a doença, advindo daí sua necessidade. A autora comprovaria a hipossuficiência econômica, pois está pela DPU, e se trata no SUS em hospital federal. Finalmente, **não se trata de fornecimento de medicamento excepcional pois o mesmo é fornecido pelo SUS, para tratar a mesma enfermidade.**

Assim, conjugando o tema 106 do STJ com o julgamento do Recurso Extraordinário 657.718/MG pelo STF, e em que pese tratar-se de uso off label, afastado pelo STJ como regra no julgamento dos embargos do Recurso Especial 1.657.156/RJ que deu origem ao tema 106, considerando tratar-se de doença com consequências raras quando ministrada a medicação tradicional, o que torna a enfermidade sem tratamento no âmbito do SUS tampouco indicação de substitutivo em território nacional, conforme manifestação do próprio NAT, e pelo fato da medicação pleiteada já ser fornecida gratuitamente pelo SUS, ainda que para outras doenças que não a da autora - o que justificaria, inclusive, seu ingresso com ação no Judiciário para obtenção - **tenho pela correção na concessão da medida.**

Por fim, em que pese toda a "preocupação" externada pelos órgãos públicos, no sentido de negar a medicação ante a ausência de indicação para seu tratamento, vale notar que a própria parte autora, e a médica que o assiste requerem a medicação, **assumem a responsabilidade pelos riscos daí advindos no tratamento pretendido**, haja vista que ingressaram na Justiça, exclusivamente, para viabilizar o fornecimento da medicação, ainda que ausente indicação específica para seu tratamento.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me à decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo a tutela e indeferindo o efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.